



מילון למפקד חוליה רפואית

מושגים ופרושם בזמן ומקום



סוגי דימום

- דימום מסכן חיים – בגד ספוג בדם, דם גולש או משפריץ מהפצע, קטיעה, תחבושת ספוגה בדם, שלולית גדולה של דם, פצוע חיוור מאוד ומחוסר הכרה עם חור (גם אם אינו מרשים כמדמם)
- דימום בלתי נשלט - דימום שלא ניתן לעצור אותו ע"י לחץ ישיר או לחץ עקיף.
- דימום נשלט - דימום שניתן לעצור אותו ע"י לחץ ישיר או לחץ עקיף.
- דימום פנימי – דימום לתוך מדורי הגוף.
- דימום חיצוני – דימום מפצע.

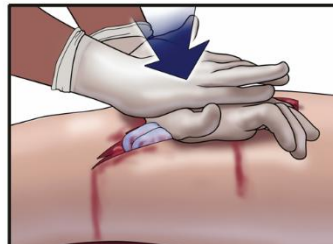




טיפול בדימום

- לחץ ישיר - אופטימאלית, חבישה באזור הפציעה. דרך מומלצת לטיפול בדימום. מצריך מינימום אור אדום. נמשך 2-4 דקות. תלוי מיקום החבישה.
דרישות מרחב: ישיבה לצד הפצוע באזור הפציעה.

- לחץ עקיף - חסימת עורקים בין פצע לבין הלב ע"י חסם עורקים. לאחר הביצוע, יש לנטר את הפצוע לעתים קרובות לשלול התחדשות דימום.

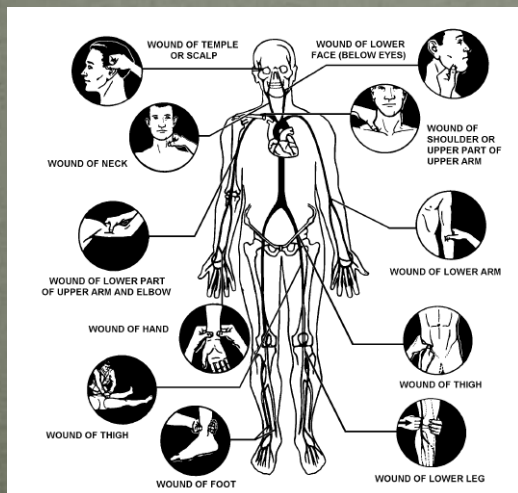




טיפול בדימום – נקודות לחיצה

- נקודת לחיצה - סוג של לחץ עקיף אותו יש לבצע כאשר לא ניתן להניח חסם עורקים. מצריך אור לבן לבקרת איכות ביצוע (הפסקת הדימום). זמן מתחילת ביצוע עד השגת הצלחה הוא 0.5-2 דקות ותלוי ביכולת לחשוף את אתר הביצוע לפעולה.

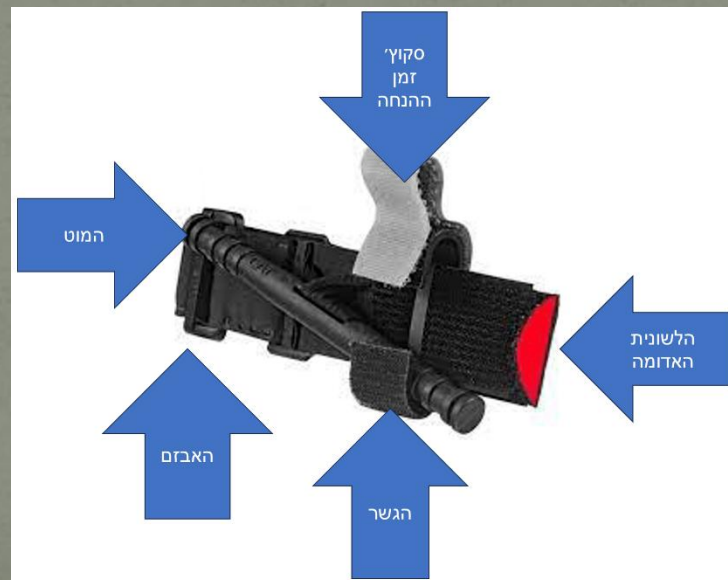
דרישות מרחב: מחייב לחץ קבוע ללא הרפייה כלל עד הגעה לבית החולים. לא מחליפים את המבצע עד ההגעה לבי"ח. המבצע לא יכול לעשות שום דבר אחר.





טיפול בדימום - קאט

- חסם עורקים - CAT או ח"ע סיליקון ירוק מגולגל. ניתן לבצע בחושך. מצריך 0.5-2 דקות תלוי בח"ע שנבחר. לאחר הביצוע, יש לנטר את הפצוע לעתים קרובות לשלול התחדשות דימום.





טיפול בדימום - פאקינג

- פאקינג - מילוי הפצע בתחבושת ארוכה על מנת לבצע לחץ ישיר עמוק ולעודד עצירת דימום. ניתן לבצע בחושך כמעט מוחלט, אך עדיף אור לבן קבוע לכיוון הפצע שמקבל טיפול.

לוקח כ 2 דקות לבצע ו 3 דקות נוספות לחץ קבוע ומתמשך לעצירת הדימום. ניתן לצמצם את הזמן הזה ע"י הנחת פירסט קייר על הפאקינג. לאחר הביצוע, יש לנטר את הפצוע לעתים קרובות כדי לשלול התחדשות דימום.





טיפול בדימום – First Care

- תחבושת ישראלית (פירסט קייר) – משמשת לקיבוע הפאקינג ושליטה על דימומים בלחץ ישיר
- זמן הנחה תלוי מיקום, 1-2 דקות





טיפול בדימום - מקבע אגן

- במידה ויש חשד לשבר באגן (מקור לדימום מסכן לחיים פנימי לחלל הבטן), יש לבצע קיבוע אגן עם התקן מיוחד.
- זמן ביצע כ 1.5 דקות
- לאחר ההנחה, על הפצוע להישאר בשכיבה על אלונקה קשיחה.





מכשירים - כללי

- מדידת לחץ דם - שימוש במכשיר לצורך הערכת חומרת מצב הלב של פצוע. מבוצע במתאר מאויים מאובטח בלבד לאחר השלמת סבב ראשוני או במהלך פינוי בלבד כל 5-15 דקות. מצריך מינימום אור אדום.
- לוקח 1-2 דקות. מהירות ההצלחה תלויה בעומק ההלם, נוחות המודד וצמצום תנועות המטופל (מדידת לחץ דם בנסיעה מאוד קשה). דרישות מרחב: הורדת תיק מט"ב





מכשירים - כללי

- פאלס / פאלסאוקסימטר - מכשיר המודד את ריווי החמצן בדם. המכשיר מייצר אור אדום.
- קבלת מדידה יד דקה (תלוי מכשיר, חומרת הלם, טמפרטורה של המטופל). ערכים שמציג המכשיר נמדדים באחוזים. ערך תקין 94-100%.
- נמצא בווסט של כל חובש/מט"ב. המכשיר מונח על האצבע ואין דרישות מרחב מיוחדות.





טיפול בדימום – דם מלא

- דם מלא – מנת דם מלא, טרי ומקורר. ניתנת לפצועים בהלם עמוק. התרופה הדחופה ביותר להינתן לפצוע עם דימום בלתי נשלט. ניתן להכין באור אדום. מצריך 5-7 דקות זמן הכנה (ערבוב של אבקה במים), וגישה ורידית או גרמית. במידה וניתן תוך גרמי, מחייב מתן עם מזרק (כ 3 דקות נוספות).





טיפול בדימום - פלזמה

- פלזמה - אבקה של מרכיבי דם המעודדים קרישה. ניתנת לפצועים בהלם עמוק. התרופה הדחופה ביותר להינתן לפצוע עם דימום בלתי נשלט (במידה ודם מלא אינו זמין). ניתן להכין באור אדום. מצריך 2-7 דקות זמן הכנה (ערבוב של אבקה במים), וגישה ורידית או גרמית. במידה וניתן תוך גרמי, מחייב מתן עם מזרק (כ 3 דקות נוספות).





טיפול בדימום - הקסקפרון

- הקסקפרון - תרופה שמעכבת את תהליך פירוק קרישי דם וכך מחזק את תהליך בניית קריש הדם. ניתן לוריד, תוך גרמי ולעתים נדירות דרך הפה. תינתן לכל פצוע עם חשד של מט"ב לדימום בלתי נשלט או הלם עמוק.



ערוצים למתן תרופות

- גישה ורידית - התקנת מחט תוך וריד. בד"כ פנים מרפק. יש להיזהר שלא לשלוף בזמן הזזת הפצוע. אופטימאלית מצריך אור לבן, ו3-5 דקות. מהירות ההצלחה תלויה בעומק ההלם, משקל, גיל. דרישות מרחב: ישיבה לצד הגפה שנבחרה.





ערוצים למתן תרופות

- גישה גרמית - התקנת מחט לתוך עצם. בד"כ שוק בסמוך לברך ע"י מכשיר בשם "NIO" או "Ezio". יש להיזהר שלא לשלוף בזמן הזזת הפצוע. מצריך לכל הפחות אור אדום. זמן ביצוע כ 3 דקות, כיוון שמצריך הכנות רבות וקיבוע טוב. דרישות מרחב: ישיבה לצד הגפה שנבחרה.





טיפול בדימום - תרופות

- נוזלים (הרטמן) - תרופה הנמצאת בשקית של חצי ליטר ומיועדת לתיקון נפח דם חסר עקב דימום או התייבשות למשל.
 - מבוצע במתאר **מאויס-מאובטח** לאחר השלמת סבב ראשוני או במהלך פינוי בלבד.
 - ✓ מחייב השגת גישה ורידית או גרמית קודם לכן.
 - ✓ יש להיזהר שלא לשלוף בזמן הזזת הפצוע.
 - ✓ מצריך מינימום אור אדום. הכנת הסט נוזלים כדקה.
- דרישות מרחב: שקית הנוזלים צריכה להיות מעל גובה הלב של המטופל או סגורה.



תרופות

- שטיפת סט - הרכבה והכנה של עירוני נוזלים למתן דרך וריד או תוך גרמי בפצוע בהלם עמוק אחרי שקיבל פלזמה. מצריך מינימום אור אדום.
- לוקח כדקה. הציוד נמצא בפקל"ח ותיק מט"ב.
- דרישות במרחב: הורדת פקל"ח/תיק מטב.





ניהול נתיב אוויר - מכשירים

- אמבו - מפוח הנשמה. לרוב ברגע שהחל שימוש בו, יש להמשיך שימוש בו עד הגעה לבי"ח.
- דרישות מרחב: ישיבה מאחורי וקרוב לראש הפצוע תוך הצמדה של מסכה בצורה אוטמת לפניו.





ניהול נתיב אוויר

- הנשמה - פעולה בה משתמש המטפל במפוח הנשמה על מנת להחליף את מאמץ הנשימה הלא תקין של הפצוע (נושם במקומו) באמצעות מפוח הנשמה או צינור בקנה הנשימה. מצריך לכל הפחות אור אדום. ברוב מוחלט של מקרים ימשך עד סוף הפינוי.
- דרישות מרחב: קירבה לראש של שני ידי המנשים, גם בזמן נידוד על גבי אלונקה במרחק של מקסימום יד מושטת.





ניהול נתיב אוויר

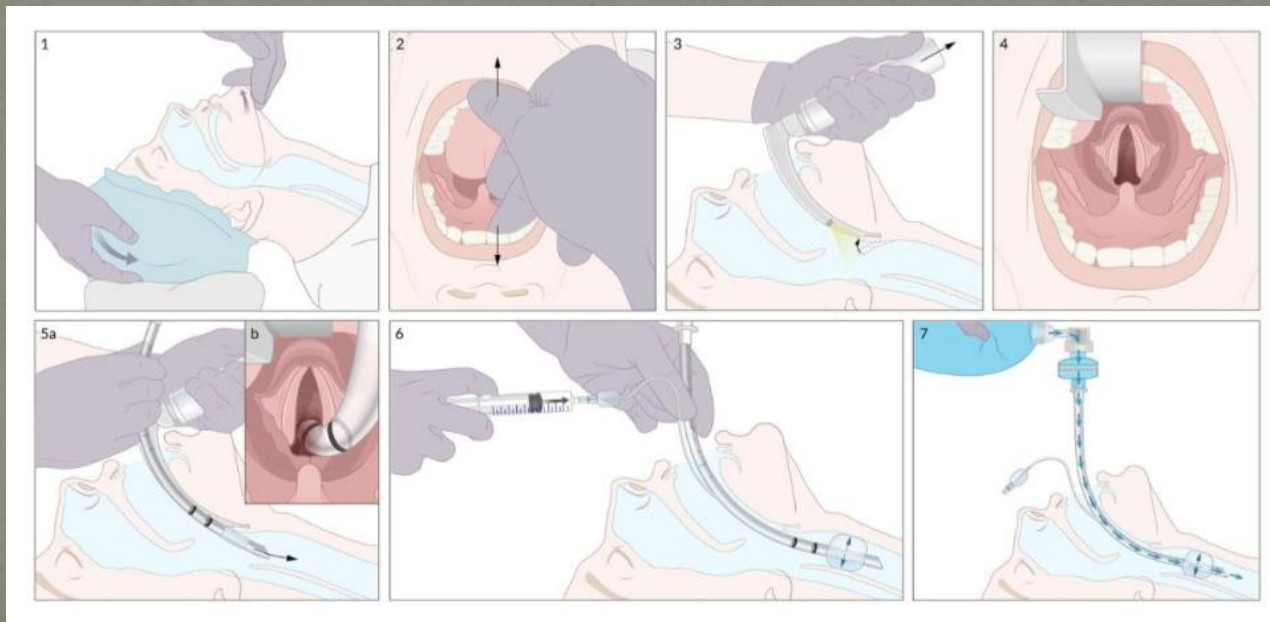
- הרדמה - שאיבה, מתן, והמתנה להשפעתן של תרופות המשרות שינה, לצורך ביצוע אינטובציה. מצריך מינימום אור אדום. דורשת 3-5 דקות ואחריה תבוא אינטובציה (0.5-5 דקות תלוי מנגנון פציעה). ההרדמה תלויה גם בהשגת גישה ורידית וכמות התרופות שיש לשאוב.
- דרישות מרחב: לרוב הורדת תיק מט"ב.





ניהול נתיב אוויר

- אינטובציה - הכנסת צינור לקנה הנשימה דרך פה באמצעות מכשיר המאיר לתוך חלל הפה. אור לבן בפה משך 10-2 דקות (זמן משתנה לפי צורך בהרדמה לפני ביצוע ומבנה אנטומיה/פציעה).
- דרישות מרחב: ישיבה/שכיבה מאחורי ראש הפצוע השוכב.





ניהול נתיב אוויר

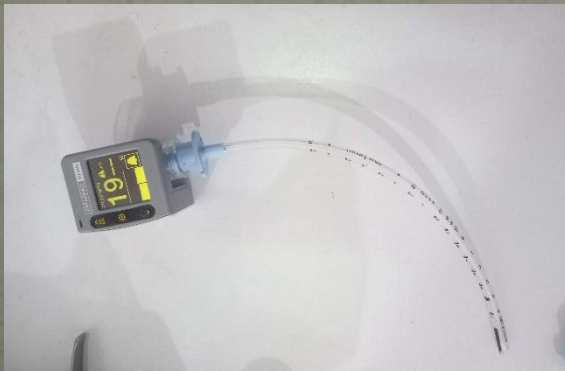
- קוניוטומיה - הכנסת צינור לקנה הנשימה דרך חתך בקידמת הצוואר וקנה הנשימה. נדרש מינימום אור אדום. זמן ביצוע 3 דקות ולאחר מכן הנשמה במפוח עד סוף הפינוי.
- דרישות מרחב: ישיבה (עדיף מימין) ליד צוואר הפצוע.





ניהול נתיב אוויר - מכשירים

- קפנו / קפנוגרף - מכשיר המודד פחמן דו חמצני היוצא בנשיפה וכך מאפשר למט"ב להעריך את איכות הנשימה, ההנשמה ואפילו קיום הדופק של מטופל. ניתן לחבר למסכת מפוח הנשמה, טובוס, קוניו.
- נמצא בתיק מט"ב.
- ערכים שמציג המכשיר נמדדים במילימטר כספית. ערך תקין 35-45 ממ"כ.





חזה אוויר בלחץ

- נידל / טי פאק / ניקור חזה באמצעות מחט - פתרון קצר טווח לחזה אוויר בלחץ ובד"כ יש צורך לחזור על הפרוצדורה כל כמה דקות. לעתים נדרש לבצע ניקור דו צידי. מומלץ מינימום אור אדום.
- זמן ביצוע כדקה. לאחר הביצוע, יש לנטר את הפצוע לעתים קרובות לשלול התחדשות לזה אוויר בלחץ.
- דרישות מרחב: חשיפה של בית החזה.





חזה אוויר בלחץ / חזה דם

- טרוקאר - ניקוז חזה האמצעות ביצוע חתך והחדרת צינור לתוך בית החזה. מהווה פתרון ארוך טווח לחזה אוויר בלחץ. לעתים נדרש לבצע נקז דו צידי (מימין ומשמאל). מצריך מינימום אור אדום.
- נמשך עד 15 דקות להשלמת הפרוצדורה. קיבוע הצינור ע"י תפרים מצריך כמה דקות כשלעצמו.
- דרישות מרחב: ישיבה לצד הפצוע באזור הפציעה.





תרופות

- דורמיקום - סם המשמש להרדמה , טשטוש או הפסקת פרכוסים.
- קטמין - סם המשמש להרדמה או ניהול כאב. עלול לגרום הזיות שליליות עם קונוטציה מינית. במקרה כזה ניתן לטפל בדורמיקום.





כאב

- ניהול כאב - מתן טיפול תרופתי לפצוע על מנת לדכא כאב. לעתים, התרופה לא תאפשר לפצוע לחזור ללחימה או אף ללכת בכוחות עצמו. לעתים מצריך גישה ורידית. לעתים מצריך גם קיבוע של גפה. לעתים ניתן לבצע גם בחושך.
- מצריך 0.5-5 דקות. תלוי בהיקף הטיפול שנדרש (השגת גישה ורידית, קיבוע גפה או אפשרות לתת אקטיק).





תרופות

- מורפיום - סם המשמש לניהול כאב בלתי נסבל של פצוע
- אקטיק / פנטניל - סם המשמש לניהול כאב בלתי נסבל של פצוע, ניתן דרך הפה, במצויה.





רטייה

- במקרה של פציעת עין יש חשיבות רבה לחבוש את העין, אך אסור להפעיל לחץ ישירות על העין.
- לכן נשתמש ברטייה קשיחה ועליה תחבושת First Care
- זמן נדרש כ-1.5 דקות, מחייב הורדת תיק מט"ב





ציוד הקיים בלבד





הדגמה של טיפול מלא

• סרטון או תצוגת תכלית

שאלות?

